

Datos Personales							
Nombre:	MARIAM RAHAL NAJMEDDINE	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2021-02-21	Edad	4 Años, 11 Meses, Y 25 Días
Identificación:	RC - 1066306764	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Islam_najm@hotmail.Com - 1066306764			Dirección:	Conjunto Cerrado Bambu Club Torre 1 Apartamento 901		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		ISLAM HAMED NAJMEDDINE - Parentesco (madre) - Teléfono (3154699065)					

Apertura psicología del 2026-02-17 19:36:31: 4 años, 11 meses, y 25 días

DATOS GENERALES

Remisión

AUTORREFERIDO - SURA Medicina Prepagada

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

“Soy brasilera, no tengo a nadie aquí de mi familia” “Me siento un poco cargada, por no tener creo que ayuda, todo es para mí” “siento que me estreso bastante con la niña” “ella se está comiendo las uñas, los dedos, hace unos meses se comía los labios”.

Enfermedad Actual

Madre consulta por cambios conductuales recientes en la menor, caracterizados por incremento en conductas oposicionistas, dificultades en la regulación emocional y desinterés progresivo en el ámbito escolar. Refiere que en los últimos cuatro meses ha observado mayor desobediencia, necesidad de repetir instrucciones múltiples veces y episodios de irritabilidad, lo que ha generado aumento en interacciones coercitivas dentro de la dinámica madre-hija. Señala dificultad para establecer límites efectivos, describiendo conductas desafiantes ante normas básicas (ej. tomar objetos prohibidos pese a indicaciones verbales). Adicionalmente, reporta conductas de hábito nervioso de inicio reciente, incluyendo onicofagia y manipulación repetitiva de uñas y dedos.

La madre identifica como posibles factores asociados la reciente transición a un nuevo entorno escolar (ingreso a kínder en institución nueva), señalando dificultades adaptativas al cambio, así como la presencia de celos hacia una hermana menor de 2 años, lo cual podría estar influyendo en la dinámica conductual actual. Se describe al menos un episodio aislado de conducta agresiva. No se reportan antecedentes previos de alteraciones conductuales significativas. Refiere preocupación por su propia respuesta emocional, refiriendo tendencia a elevar el tono de voz ante la frustración y deseo de adquirir estrategias para mejorar la interacción y manejo conductual.

También refiere consumo elevado de dulces en la menor y dificultad para establecer límites en este ámbito. Menciona antecedentes de alta ingesta de azúcar durante la gestación. Clínicamente se observa permisividad en la regulación de este hábito, el cual se sugiere abordar en intervención.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

NO REFIERE

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

NO REFIERE

Patología

NO REFIERE

Tóxicos

Medicación

NO REFIERE

Hospitalizaciones

SI, POR INFECCIÓN EN EL OÍDO

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 34 AÑOS	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo PRIMER	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Emociones Reguladas. Durante La Gestación La Madre Refiere Consumo Elevado De Dulces, Sin Complicaciones Médicas Reportadas.

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea PLAQUETAS BAJAS
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3350
Talla Al Nacer 49	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido NO REFIERE
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 10M
Bípodo Sin Ayuda 11M	Marcha 14M
Lenguaje Verbal 7M	Lenguaje Verbal Fluido 4 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos NO REFIERE	Otros NO REFIERE

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa La menor se encuentra actualmente cursando nivel kínder (K4) en el colegio La Sierra. Refiere antecedente escolar previo en la institución “Toy Feliz”. Según reporte materno, la transición entre instituciones ha representado un cambio significativo, asociándose a manifestaciones recientes de alteración conductual y emocional. No obstante, se describe adecuada capacidad de integración social, logrando vincularse con pares y participar en actividades escolares, pese a las dificultades adaptativas iniciales relacionadas con el cambio de entorno educativo.
Historia laboral NO APLICA
Historia familiar La menor convive actualmente con ambos padres el Sr. Saahd Rahal tarbine de 45 años y madre la Sra. Islam Hamed Neajmeddine de 38 años y la hermana menor Amera Rahal Hamed de 2 años. Según reporte materno, el ambiente familiar es globalmente funcional y se describe una dinámica de convivencia estable. No obstante, se identifican dificultades ocasionales en la comunicación intrafamiliar, especialmente en el contexto del manejo conductual reciente de la menor. Los cuidadores se encuentran en proceso de ajuste y búsqueda de estrategias para

abordar los comportamientos actuales, particularmente aquellos relacionados con oposición, regulación emocional y adaptación a cambios recientes en el entorno.

Historia social Según reporte materno, la menor presenta adecuado desempeño en el área social, caracterizándose por facilidad para la interacción con pares, actitud sociable y disposición prosocial. Se describe como una niña empática, con tendencia a compartir objetos personales (juguetes, meriendas) y mostrar interés por el bienestar de otros. No obstante, se reportan dificultades conductuales situacionales, especialmente en contextos de establecimiento de normas y límites, donde puede manifestar conductas oposicionistas o desobediencia ante indicaciones del adulto.
Historia emocional/afectiva La menor se describe como una niña alegre, afectuosa y con buen nivel de participación en diferentes contextos, evidenciando iniciativa en la interacción y adecuada disposición emocional. Se observan recursos cognitivos acordes a su edad, con buena capacidad de respuesta ante estímulos del entorno. No obstante, se reportan dificultades en la regulación emocional, manifestadas en episodios de berrinches, oposición ante normas y baja tolerancia a la frustración, especialmente cuando no se satisfacen sus deseos inmediatos. Estas conductas se presentan de forma situacional, principalmente en contextos de establecimiento de límites por parte de figuras de autoridad.
Historia deportiva NO REFIERE

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial Se realiza entrevista semiestructurada con la menor, orientada a explorar áreas socioemocionales, percepción familiar y recursos adaptativos acordes a la etapa evolutiva. Se complementa la evaluación mediante la aplicación de técnica proyectiva gráfica (Test de la Familia), con el objetivo de explorar la representación simbólica del entorno familiar, vínculos afectivos y vivencias emocionales asociadas. La menor participa de manera colaboradora durante la actividad, mostrando disposición adecuada para la interacción y comprensión de la consigna. Se procede a análisis cualitativo del material gráfico según lineamientos interpretativos de Louis Corman. Se realiza análisis cualitativo del dibujo familiar según lineamientos proyectivos de Louis Corman. El material gráfico evidencia un nivel evolutivo acorde a la edad cronológica, con representación esquemática esperada para etapa preescolar. La menor incluye a los miembros principales del sistema familiar, sin omisiones relevantes, sugiriendo percepción de estructura familiar integrada. Se observa predominio de una figura adulta de mayor tamaño, lo cual podría asociarse a la representación de la figura de apego principal. La disposición espacial muestra cercanía entre los miembros, sin indicadores gráficos de aislamiento o rechazo vincular. El trazo es suave y organizado, sin signos de presión excesiva o sombreado, lo que no sugiere indicadores de ansiedad elevada desde lo proyectivo. La inclusión de elementos ambientales (ej. sol) sugiere vivencia emocional globalmente positiva del entorno familiar. En conjunto, el material no evidencia indicadores proyectivos de conflicto emocional severo, siendo compatible con un funcionamiento socioafectivo acorde a la etapa evolutiva, con posibles manifestaciones conductuales situacionales relacionadas con procesos adaptativos recientes.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica NO REFIERE
Intervención neurológica NO REFIERE
Intervención neuropsicológica NO REFIERE
Otras intervenciones Se reporta antecedente de intervención por fonoaudiología durante aproximadamente cinco meses, iniciando en septiembre de 2025, debido a dificultades en el desarrollo del lenguaje expresivo, caracterizadas por baja fluidez y limitada claridad articulatoria para la edad. Según reporte del acudiente y la observación realizada, la menor presentó evolución favorable durante el proceso terapéutico, evidenciándose actualmente mejoría significativa en la fluidez verbal y comprensión del discurso, logrando una comunicación más clara y funcional acorde a su etapa del desarrollo.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental La paciente ingresa a consulta en adecuado estado de alerta y conciencia, con presentación personal acorde a la edad y contexto. Se observa activa durante la sesión, con alta energía motora y rasgos de inquietud psicomotora compatibles con su etapa del desarrollo. Establece contacto visual funcional, responde al llamado por su nombre y mantiene interacción espontánea con el evaluador. Se comunica de manera verbal acorde a su edad, logrando expresar preferencias, intereses y necesidades básicas con claridad. Comprende y sigue instrucciones simples y dobles. Se muestra participativa, exploratoria y con adecuada curiosidad por el entorno, eligiendo actividades de manera autónoma. La atención se observa fluctuante pero funcional para la edad, con capacidad de redirección mediante guía verbal. A nivel afectivo se muestra expresiva, con adecuado rango emocional, sin evidencias de tristeza persistente ni inhibición conductual. No se observan conductas autoagresivas ni heteroagresivas durante la sesión. Pensamiento acorde al nivel evolutivo, sin alteraciones del contenido evidentes. Lenguaje comprensible y funcional. Juicio y control de impulsos en proceso de maduración, acorde a la etapa del desarrollo. No se evidencian alteraciones sensorio-perceptivas aparentes durante la evaluación.
Ciclos del Sueño CONSERVADOS
Apetito CONSERVADOS
Actividades de Autocuidado En el área de hábitos de autocuidado, la paciente se encuentra en proceso de adquisición del control de esfínteres. Según refiere la madre, recientemente ha presentado avances en el control urinario; sin embargo, aún requiere supervisión y acompañamiento para la consolidación del hábito. El proceso se encuentra dentro de parámetros esperados para la edad, en fase de maduración.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V): Z628 - OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS Y RELACIONADOS CON LA CRIANZA DEL NINO Impresión Diagnóstica Relacionada 1 NREF - NO REFIERE Impresión Diagnóstica Relacionada 2
--

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

El cuadro actual es compatible con dificultades en la regulación emocional propias de la etapa preescolar, asociadas a procesos adaptativos recientes, incluyendo transición escolar y reconfiguración de la dinámica familiar tras el nacimiento de una hermana menor. No se evidencian indicadores de psicopatología estructurada. El funcionamiento global se encuentra conservado, con recursos socioafectivos adecuados y manifestaciones conductuales situacionales esperables para la edad.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer la regulación conductual y emocional de la menor mediante intervención en habilidades socioemocionales y fortalecimiento de competencias parentales orientadas al establecimiento de límites claros, consistentes y afectivos.

Objetivos Específicos

- **Fortalecer habilidades de autorregulación emocional** en la menor mediante estrategias lúdicas adaptadas a su etapa evolutiva.
- **Disminuir conductas oposicionistas y berrinches** a través de técnicas de modificación conductual basadas en refuerzo positivo y economía de fichas.
- **Facilitar la adaptación al nuevo entorno escolar**, promoviendo seguridad emocional y ajuste progresivo a los cambios recientes.
- **Trabajar celos fraternos y manejo de rivalidad entre hermanas**, favoreciendo conductas prosociales y sentido de pertenencia familiar.
- **Regular hábitos conductuales asociados al consumo excesivo de dulces**, mediante estructuración de normas familiares coherentes.
- **Fortalecer el vínculo madre-hija** mediante espacios de interacción positiva guiada.
- **Entrenar a los cuidadores en habilidades de crianza positiva**, incluyendo:

1. establecimiento de límites consistentes
2. manejo de berrinches
3. validación emocional sin sobrepermisividad
4. uso adecuado de consecuencias

Sugerencias e Interconsultas

Actualmente no se consideran necesarias remisiones prioritarias, dado que:

- Desarrollo global conservado
- Lenguaje en evolución favorable
- No signos de trastornos del neurodesarrollo

Observaciones y Recomendaciones

???OBSERVACIONES

- La sintomatología actual se presenta en contexto evolutivo temprano, sin indicadores de psicopatología estructurada.
- Se identifican factores ambientales relevantes, especialmente relacionados con estilos de crianza permisivos y cambios recientes en el entorno escolar.
- La menor presenta buen potencial adaptativo, con recursos socioafectivos conservados (sociabilidad, empatía, lenguaje funcional).
- La intervención temprana centrada en familia tiene alto pronóstico de evolución favorable.

RECOMENDACIONES

Para padres

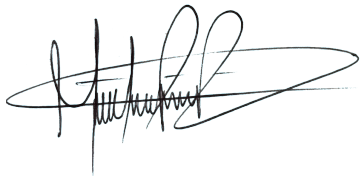
- Establecer normas claras, breves y consistentes.
- Evitar negociaciones durante berrinches.
- Aplicar consecuencias inmediatas y proporcionales.
- Reforzar conductas positivas más que castigar negativas.
- Implementar rutinas estructuradas (sueño, alimentación, pantallas).
- Regular consumo de azúcar mediante acuerdos familiares progresivos.
- Evitar ceder ante conductas oposicionistas reforzadas por llanto o insistencia.

En casa

- Tiempo exclusivo madre-hija diario (10–15 minutos).
- Uso de tablas de refuerzo visual.
- Lenguaje emocional simple (“entiendo que estás molesta”).
- Evitar gritos como estrategia correctiva.

En colegio

- Mantener comunicación con docentes durante proceso adaptativo.
- Uso de refuerzo positivo en aula.
- Evitar etiquetamiento conductual.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER